



ORIGINAL

La experiencia emocional de enfermeras de la Unidad de Hospitalización a Domicilio en cuidados paliativos: un estudio cualitativo exploratorio



Paula Barrué^{a,*} y Martín Sánchez-Gómez^b

^a Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castellón de la Plana, Castellón, España

^b Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Castellón, España

Recibido el 21 de octubre de 2019; aceptado el 14 de noviembre de 2020

Disponible en Internet el 3 de febrero de 2021

PALABRAS CLAVE

Fatiga por compasión;
Satisfacción laboral;
Burnout;
Cuidados paliativos;
Enfermería;
Atención domiciliaria

Resumen

Objetivo: Explorar las emociones experimentadas por las enfermeras de una Unidad de Hospitalización a Domicilio como resultado de su rol laboral.

Método: Estudio exploratorio cualitativo, con enfoque desde la fenomenología para explorar experiencias y vivencias de la vida interior de las personas. Las participantes fueron 9 enfermeras que desempeñaban su labor en la Unidad de Hospitalización a Domicilio. Se realizó un análisis de contenido cualitativo. Las unidades de significado fueron agrupadas en 13 códigos que, a su vez, se clasificaron en 4 categorías llamadas dimensión emocional, aspectos beneficiosos y angustiantes, vida laboral diaria y vida personal.

Resultados: Las enfermeras que trabajan en cuidados paliativos sufren una exposición continua a situaciones traumáticas, aunque también refieren sentir emociones satisfactorias que compensan los momentos de angustia. Poseer recursos como formación en autocuidado y regulación emocional, así como contar con apoyo social, parece ser clave para prestar una atención de calidad y evitar la aparición de la fatiga por compasión.

Conclusiones: Mantener el bienestar psicosocial en el lugar de trabajo resulta crucial para que los profesionales sanitarios dedicados a los cuidados paliativos puedan desempeñar su labor de la mejor forma posible.

© 2020 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: paulabarrue@gmail.com (P. Barrué), sanchgom@uji.es (M. Sánchez-Gómez).

<https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.11.006>

1130-8621/© 2020 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Compassion
satisfaction;
Job satisfaction;
Burnout;
Hospice and palliative
care nursing;
Nursing;
Home care services

The emotional experience of nurses in the Home Hospitalization Unit in palliative care: A qualitative exploratory study

Abstract

Objective: To explore the emotions experienced by the nurses of a Home Hospitalization Unit as a result of their work role.

Method: A qualitative exploratory study was carried out with a phenomenology approach to explore people's experiences and inner-life experiences. The participants were 9 nurses working in the home hospitalization unit. An analysis of qualitative content was undertaken. Units of meaning were grouped into 13 codes that, in turn, were classified into 4 categories, emotional dimension, beneficial and distressing aspects, daily working life and personal life.

Results: Nursing professionals working in palliative care suffer continuous exposure to traumatic situations, although they also report feeling satisfactory emotions that compensate for moments of distress. Having resources such as training in self-care and emotional regulation, as well as social support seems to be key to providing quality care and avoiding the onset of compassion fatigue.

Conclusions: Maintaining psychosocial well-being in the workplace is crucial for palliative care nurses to be able to undertake their work in the best possible way.

© 2020 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

¿Qué se conoce?

El trabajo en cuidados paliativos supone acompañar en el sufrimiento y dolor de las personas en los momentos más difíciles de su vida. Esta situación puede facilitar la aparición de fatiga emocional por el impacto acumulativo del cuidado y atención prestada por parte de los profesionales de la salud.

¿Qué aporta?

Esta investigación descubre los aspectos que más influyen en el desempeño laboral de la enfermera en cuidados paliativos y pone de manifiesto que fatiga y satisfacción no son conceptos excluyentes.

Introducción

La profesión enfermera no solo está reconocida por la acción de cuidar, sino por la labor que desempeña en la provisión de apoyo a pacientes y familiares en distintas fases de la enfermedad¹. En este contexto, distintas investigaciones han estudiado las consecuencias de este trabajo en los profesionales sanitarios, pudiendo desembocar en desgaste emocional, burnout y fatiga por compasión (FC)^{2,3}. Perez et al.² definen la compasión como la emoción resultante de sentir preocupación por el sufrimiento ajeno a la vez que se desea conseguir el bienestar de esa persona. En cuanto al burnout, definido como un síndrome psicológico caracterizado por el agotamiento emocional, la despersonalización y el bajo logro personal resultado del estrés laboral crónico⁴,

en torno al 66,6% de los enfermeros en España presentan algún síntoma³.

En unidades como la de Geriátrica o Cuidados Paliativos, en las que hay un contacto frecuente con pacientes en situación terminal, resulta especialmente complejo el manejo emocional⁵. Los profesionales que ejercen su labor en estas unidades crean un vínculo emocional con los pacientes y su entorno, empatizando con su pérdida, lo que puede generar sentimientos de futilidad o de haber fallado en el cuidado⁵⁻⁸. Este hecho resulta un factor de riesgo para padecer FC, término acuñado por Joinson⁹ para describir una serie de comportamientos que padecían las enfermeras de urgencias hospitalarias en distintos países^{6,7,10}. Así pues, al desgaste producido por el trabajo con personas se le une, en el caso general de los profesionales sanitarios y en el particular de los enfermeros de unidades de oncología y cuidados paliativos, la fatiga que se genera en la relación de ayuda⁵.

En el profesional enfermero, la FC puede suponer cansancio crónico, irritabilidad, temor al trabajo, empeoramiento de las dolencias físicas, falta de alegría y un descenso en la capacidad para cuidar^{7,10-12}. Considerado un síndrome de desgaste, se asocia con malestar físico, depresión, ansiedad, somatización, alteración negativa de las creencias, dificultades sociales y familiares, abandono de la profesión y ausentismo, desempeño laboral deficiente y consumo de sustancias^{13,14}. Abendroth y Flannery¹⁵ observaron que el 26% de los enfermeros en cuidados paliativos presentaba un alto riesgo de desarrollar FC y un 52% un riesgo moderado.

A pesar de la frecuencia de situaciones de sufrimiento que se producen en cualquier servicio de Cuidados Paliativos, sus profesionales no son los más afectados por fenómenos como el burnout o la FC¹⁶. Esta prevalencia no es tan alta como cabría esperar por la existencia de factores protectores¹⁷. Destacan entre estos el asesoramiento, la ayuda psicológica, los grupos de soporte, las técnicas de relajación, las habilidades emocionales, la empatía y la com-

petencia de afrontamiento ante la muerte^{5,18,19}. Otro factor de prevención de la FC y el burnout son las actividades de autocuidado, ya que ayudan a la promoción personal y al crecimiento espiritual^{6,20}. El modelo de autocuidado basado en la conciencia de Kearney identifica una relación positiva entre el nivel de autoconciencia de los profesionales y la satisfacción por compasión (SC)¹⁹. Stamm⁵ define la SC como un sentimiento de logro y gratificación personal por ayudar a quienes están en situaciones que generan estrés y sufrimiento. Esta satisfacción surge de sentirse competente y hábil en lo profesional al contribuir al bienestar social¹³.

Estos 3 constructos, FC, SC y burnout, parecen estar relacionados con la calidad de vida profesional⁵, así como con el riesgo de cometer errores¹³, por lo que resulta de vital importancia explorarlos en esta población²¹.

El principal objetivo de este trabajo es explorar las emociones experimentadas por enfermeras de una Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) como resultado de su rol laboral.

El segundo objetivo es conocer posibles condiciones que puedan favorecer la aparición de la FC o SC.

Método

Diseño

Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo y transversal que utiliza una estrategia de estudio de casos múltiples con enfoque fenomenológico para explorar las experiencias y vivencias de la vida interior de las trabajadoras.

Participantes

Se llevó a cabo un muestreo intencional²². Formaron parte de este estudio enfermeras de una UHD. Esta unidad ofrece atención sanitaria enfocada a proporcionar cuidados especializados de carácter hospitalario a los pacientes en su propia casa. Además, la UHD evaluada atiende con asiduidad a pacientes en situación terminal, los cuales son ayudados a finalizar el proceso de enfermedad en su entorno y junto a sus seres queridos. Con frecuencia, esta unidad cuenta con pacientes geriátricos, con necesidades de cuidados paliativos, nutrición artificial y de soporte hematológico.

Los criterios de inclusión fueron trabajar en la UHD a tiempo completo, tener la diplomatura o el grado en enfermería y la disposición para participar; además, no se especificó ningún límite temporal relacionado con la experiencia laboral.

Recogida de datos

Para la recogida de datos, se utilizó la entrevista semiestructurada previamente elaborada (anexo 1). Esta técnica posee un estilo abierto que permite extraer una gran riqueza informativa. Además, el entrevistador tiene la posibilidad de clarificar aquellas respuestas en las que no queda claro el contenido, es decir, es una técnica de interacción personalizada, flexible y espontánea. El primer contacto fue telefónico al comienzo del estudio y el siguiente, también mediante teléfono se realizó unas semanas antes del

momento de la entrevista. Cabe destacar la no existencia de ningún tipo de relación amistosa/profesional previa con las participantes.

Las entrevistas fueron realizadas desde mayo del 2018 hasta enero del 2019 de forma presencial por los 2 investigadores principales. El lugar escogido fue un despacho de la UHD, donde se disfrutó de un ambiente tranquilo sin interrupciones.

Se realizó un diario de campo en el que se registraron diversos aspectos: desarrollo, registro de observación, registro de las reuniones, percepciones, sensaciones y comunicación no verbal como gestos, suspiros, etc. Todo ello ayudó a interpretar los resultados y nutrir el análisis.

Validez y fiabilidad/rigor

Un investigador externo realizó una valoración del protocolo de investigación del estudio, prestando especial atención al diseño y método aplicado. La transferibilidad se fortalece mediante una descripción clara del contexto, de la selección de participantes, de la recogida de datos y del proceso de análisis²³. El criterio de credibilidad se apoya en el uso de recursos técnicos como la triangulación con literatura científica preexistente, la triangulación por 2 investigadores y por la validación de las participantes del material obtenido en la recogida de datos²³.

Análisis de datos

El estudio de los datos obtenidos se realizó mediante un análisis de contenido cualitativo. La etapa de análisis fue fragmentada en 5 fases. En la primera, la entrevista y la transcripción fueron revisadas por las participantes. En la segunda fase se releeron los textos para obtener las unidades de significado, es decir, se relacionaron las declaraciones con un código a través de su contenido y contexto. En la tercera fase se extrajeron citas importantes y se procedió a clasificarlas en códigos, produciéndose la codificación²⁴. Como soporte en el proceso de categorización y codificación se utilizó el programa Atlas.ti versión 8.3.0 (Scientific Software Development GmbH; Berlin, Alemania). El análisis cualitativo presentado es el resultado de un proceso deductivo que combina categorías preestablecidas con otras construidas a partir de los datos y los presupuestos de los investigadores (método inductivo). Durante la cuarta fase, se agruparon categorías que permitieron revelar significados potenciales y empezar a desarrollar ideas. En la última fase se interpretaron los datos. Se aplicaron todos los criterios de la guía COREQ para estudios cualitativos.

Consideraciones éticas

Siguiendo las pautas de la Declaración de Helsinki²⁵, se preservó la intimidad de cada participante y la confidencialidad de su información personal²⁶. Este proyecto fue aprobado por la Comisión de investigación del Consorcio Hospitalario Provincial correspondiente.

Todas las participantes firmaron un consentimiento escrito donde se describía tanto la finalidad y objeto del estudio, como la participación voluntaria y la posibilidad de

Tabla 1 Características sociodemográficas de las enfermeras entrevistadas

Enfermera	Edad	Años de experiencia profesional como enfermera	Nivel educativo alcanzado	Estado civil
E1	28	1	Diplomatura	Soltera sin hijos
E2	34	6	Diplomatura y cursos formativos	Casada con hijos
E3	35	4	Diplomatura y cursos formativos	Casada con hijos
E4	41	7	Diplomatura, cursos formativos y máster	Casada con hijos
E5	43	10	Diplomatura, cursos formativos y máster	Soltera sin hijos
E6	44	11	Diplomatura y cursos formativos	Casada con hijos
E7	46	9	Diplomatura, cursos formativos y máster	Casada con hijos
E8	55	12	Diplomatura, cursos formativos y máster	Divorciada con hijos
E9	58	17	Diplomatura y cursos formativos	Casada con hijos

Fuente: elaboración propia.

abandonar el estudio en cualquier momento²⁵. Del mismo modo, aceptaron el consentimiento para grabar y transcribir las entrevistas, las cuales fueron codificadas mediante la letra E más el número de entrevista, según el orden de realización.

Resultados y discusión

Fueron contactadas las 9 trabajadoras de la UHD, participando el 100% de ellas. La duración media de la entrevista estuvo entre 35 y 60 min. La media de años trabajados en la UHD fue 9,5 años (DE 4,1). La [tabla 1](#) muestra los valores de las diferentes variables sociodemográficas registradas.

A partir del análisis de la bibliografía y de la extracción de los datos surgieron 4 categorías principales, de las que se originan 13 códigos con sus correspondientes unidades de significado ([fig. 1](#)). La primera de estas categorías, dimensión emocional, hace referencia a las emociones experimentadas por las participantes. En segundo lugar, la categoría aspectos beneficiosos y angustiantes recoge las situaciones en las que las participantes habían sentido fatiga o satisfacción en su ámbito laboral. La tercera categoría, vida laboral diaria, describe cómo desempeñan su función profesional, su relación con los compañeros y cómo abordan la carga laboral. Por último, la categoría vida personal explora las dificultades presentes en el trabajo y su influencia en la vida personal. En el [anexo 2](#), se describen las categorías, sus códigos y las unidades de significado más relevantes.

A continuación, se detallan y discuten los resultados obtenidos en cada una de las categorías.

Dimensión emocional

De forma deductiva, se crearon 3 códigos: sentimientos y sensaciones, dificultades y compasión, mientras que de forma inductiva se incorporó: crecimiento emocional. En esta categoría las enfermeras describen aquello que, debido a su profesión, experimentan emocionalmente, tanto en una jornada laboral como en su vida personal, como resultado de su labor en la UHD.

Con relación al código sentimientos y sensaciones, gran parte de las unidades de significado hacen referencia a la

sensación de no tener la situación bajo control debido a que el trabajo en la UHD es cambiante, sin embargo, toda la muestra coincide en sentir alegría al acudir al trabajo.

«En este servicio hay un plus, el de las emociones. Este trabajo es bastante enriquecedor a nivel profesional porque interactúas con el paciente de forma integral». (E.4).

El segundo código, dificultades, recoge situaciones, circunstancias u obstáculos difíciles de superar. Las entrevistadas reflejan las situaciones más difíciles de manejar mostrándolas como dificultades en su camino laboral.

«Cuando te sientes algo identificado es mucho más duro, al menos para mí». (E.1).

El tercer código de esta categoría es la compasión. Considerada una emoción compleja que se experimenta al sentir el sufrimiento ajeno y que supone una mezcla de tristeza y amor.

«Hay quien dice que la compasión es inagotable, pero yo pienso que tienes que estar muy preparado para poder compartir, dar, ofrecer esa compasión sin agotarte y pienso que es muy importante saber dónde estás tú y de separar bien lo que es tuyo y lo que es de los demás». (E.6).

El último código hace referencia al crecimiento emocional, a través del cual se observa una mejora en la capacidad de percibir y gestionar emociones con el paso del tiempo y la experiencia profesional.

«Cuando comencé en esto era muy difícil no dejarme superar por el contexto, todo me impactaba y me iba a casa muy afectada. Sin embargo, poco a poco he ido mejorando mucho mi manera de reaccionar y soy capaz de gestionar mejor emociones como la frustración». (E.9).

Los resultados en la categoría «dimensión emocional» señalan cómo la práctica clínica diaria afecta a las enfermeras como consecuencia de la exposición continua a situaciones traumáticas de los pacientes. Las dificultades emocionales vienen dadas por la sensación de no tener la situación bajo control, algo entendible si recordamos que tanto el tipo de trabajo, como la localización en la UHD, es cambiante. De la misma forma, declaran que tratar con

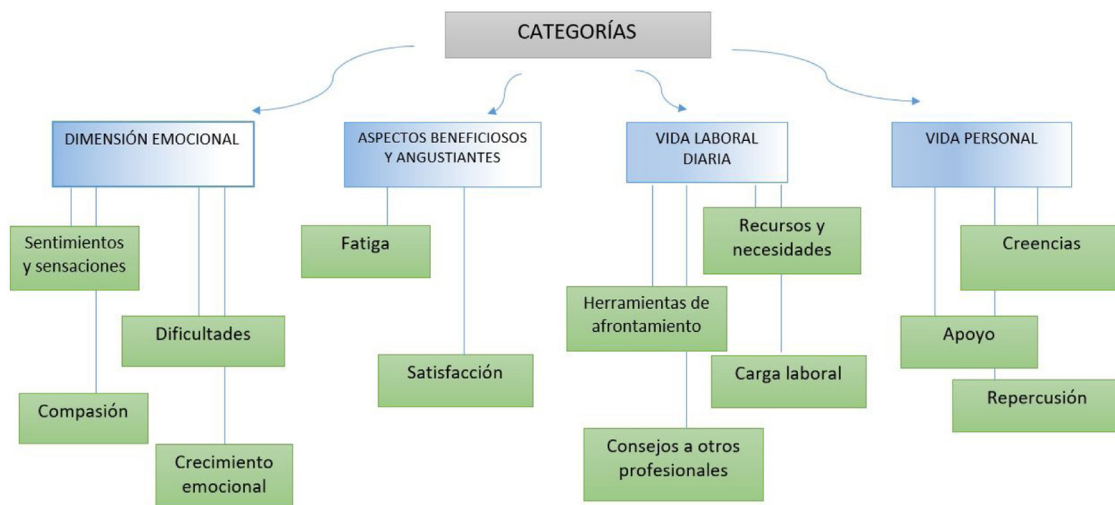


Figura 1 Categorías y códigos.

pacientes conocidos o con niños y adolescentes favorece la aparición de estrés y una mayor carga emocional. Además, las participantes consideran que sus problemas personales pueden influir a la hora de prestar cuidados de calidad y pueden contribuir a una desestabilización emocional, lo que coincide con el estudio de Ray et al.²⁷. Pese a ello, diversos aspectos positivos emergen facilitando el desempeño de la labor en la UHD. Por ejemplo, la totalidad de la muestra coincide en sentir alegría al acudir al trabajo, un factor protector observado en trabajos previos^{18,19}. Además, las participantes describen que trabajar en el domicilio del paciente permite abordar la situación de una forma integral, conociendo de forma profunda la situación personal del enfermo y creando lazos de unión profesional-paciente más fuertes que en el ámbito hospitalario. Por último, se aprecia un desarrollo emocional a medida que suman experiencias laborales, así como un creciente interés por conocer sus sentimientos.

Aspectos beneficiosos y angustiantes

Esta categoría alberga los códigos fatiga y satisfacción. Ambos derivan del concepto de compasión, teniendo la fatiga un sentido negativo y la satisfacción uno positivo. A lo largo de la categoría se describen aquellos aspectos que las enfermeras consideran beneficiosos de su puesto, así como las situaciones negativas o angustiosas fruto de su labor en la UHD.

En cuanto a los aspectos positivos, todas las enfermeras estuvieron de acuerdo con hablar de los cuidados paliativos como una oportunidad que les brinda su profesión para aportar todo el bienestar posible en los últimos momentos de vida del paciente.

«[...] a mí me provoca una enorme satisfacción que a través de mi trabajo y mi formación tenga una escala de valores en mi vida personal, entonces, me parece que me da mucha más satisfacción que otra cosa» (E.3).

En el lado opuesto, las enfermeras describen las situaciones cercanas a la muerte como las menos agradables y, a su vez, predisponentes de fatiga.

«Me sentía muy mal al verla en ese momento de enfado, se iba a morir sin llegar a tener una aceptación y fue muy duro sedarla, la situación era desagradable...». (E.1).

Tras analizar las respuestas, se puede concluir que experimentan una enorme satisfacción en determinados momentos como cuando los familiares les agradecen haber ayudado a su familiar a poder irse en paz, en casa y rodeado de sus seres queridos. Sin embargo, también sufren situaciones que generan angustia o estrés emocional, como el frecuente fallecimiento de pacientes, lo que acentúa la sensación de fatiga. Pese a ello, todas reflejaron en las entrevistas que, si pusiesen en una balanza el concepto de fatiga y satisfacción, tendría mucho más peso el segundo concepto, demostrando así que el tratar con pacientes paliativos puede ser mucho más reconfortante de lo que se suele pensar²⁸.

Vida laboral diaria

En esta categoría fueron incluidos, de manera deductiva, los códigos recursos y necesidades, herramientas de afrontamiento y consejos a otros profesionales. De forma inductiva, se dio entrada a la categoría carga de trabajo.

Los recursos se entienden como la ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. En el contexto de este estudio, las enfermeras declararon contar con diversos recursos que utilizan en su práctica habitual, especialmente a la hora de afrontar situaciones estresantes.

«Hace poco hablábamos de lo importante que es tener un espacio para hablar de las emociones en este trabajo». (E.3).

«Para mí, el recurso fundamental es conocerme y nutrirme para poder acompañar a los demás». (E.6).

Las enfermeras describen los talleres de formación, en concreto aquellos relacionados con autoconocimiento, mindfulness y notificación de malas noticias, como herramientas fundamentales para afrontar su labor y gestionar adecuadamente las demandas a las que se enfrentan.

«Me di cuenta de que necesitaba formarme y tener recursos porque no puedes ir a la guerra sin armas, necesitas herramientas». (E.6).

«Cualquier herramienta que te permita trabajar emociones repercutirá en una mejor gestión de las situaciones cotidianas». (E.3).

En cuanto a los consejos a otros profesionales, las entrevistadas resaltaron la dificultad de trabajar en la UHD, ya que se trata de un trabajo complejo que requiere una alta profesionalidad. Las enfermeras declararon desempeñaron un papel fundamental en el proceso de adaptación de las nuevas compañeras, especialmente aquellas recién salidas de la facultad. Además, ofrecieron una serie de consejos para nuevos profesionales en esta unidad.

«Les hemos tenido que animar mucho y estar mucho a su lado dándoles ánimos porque no es fácil y entendemos que cuesta, y que no es uno de los sitios que una persona recién acabada de la carrera pueda trabajar aquí con facilidad...». (E.2).

«Que trabajen mucho la empatía para entender la situación en la que se encuentran pacientes y familias, y después saber separar vida laboral y personal». (E.5).

Para finalizar, las enfermeras hicieron hincapié en la excesiva carga laboral a la que se ven sometidas casi de forma diaria, así como a la constante atención que requiere su puesto.

«En ocasiones este trabajo te sobrepasa, no cabe duda que necesitas estar muy unida o él para no abandonar». (E.8).

«A veces noto que las demandas son excesivas, necesitamos estar bien preparadas para que toda la carga nos afecte lo menos posible». (E.4).

Según los datos recogidos, la vida laboral de las enfermeras se caracteriza por afrontar una alta carga de demandas y situaciones cambiantes de forma casi diaria. Anderson et al.²⁹ indican que muchos enfermeros se sienten poco preparados cuando afrontan situaciones con pacientes en situación agónica debido a una falta de conocimientos en cuidados paliativos. Estas demandas pueden ser solventadas mediante la formación en habilidades concretas. En esta línea, Colell Brunet et al.³⁰ proponen una formación específica en cuidados paliativos para aquellos enfermeros que ejerzan su labor con enfermos avanzados o en fase final de la vida.

Además de esto, contar con ayuda de recursos como el autocuidado, especialmente importante a la hora de enfrentar la exposición frecuente a la muerte¹⁹, puede resultar de gran ayuda. Sansó et al.¹⁹ identificaron en su estudio que los profesionales con un alto nivel de autocuidado y conciencia plena poseen niveles inferiores en FC y más satisfacción, por lo que su desarrollo podría reducir el impacto de las

demandas en cuidados paliativos^{19,31}. Otro recurso fundamental en el ámbito de la enfermería es la empatía, la cual parece desempeñar un papel clave en la prevención de la soledad y el desgaste, así como en la promoción de la satisfacción vital¹⁸. En cuanto a los consejos a otros profesionales, destacan la importancia del apoyo entre compañeros, especialmente si son noveles. Durante las primeras prácticas clínicas es frecuente experimentar altos niveles de estrés³². Además, también enfatizan la necesidad de una adecuada preparación más allá de los conocimientos adquiridos en la carrera, ya que desde que un enfermero se gradúa hasta que comienza a trabajar, debe adquirir competencias como el afrontamiento ante la muerte que le permitan proporcionar cuidados de calidad^{19,33}.

Vida personal

Esta categoría explora cómo, además de en el ámbito profesional, el rol laboral repercute en el entorno familiar y social del profesional. Fueron incluidos, de manera deductiva, los códigos apoyo y repercusión y, de forma inductiva, el código creencias.

En lo relativo al apoyo recibido, las enfermeras lo entienden como una ayuda fundamental a la hora de evitar la sobrecarga emocional que conlleva el trato con el paciente en situación terminal.

«Momento de café y de interacción entre compañeros. Hay muy buen equipo y te sientes respaldada cuando cuentas las cosas que te han pasado». (E.1).

En cuanto a la repercusión social que tiene su trabajo, se encuentran discrepancias, ya que parte de la población piensa que el desempeño de su labor les afecta de forma negativa, mientras que ellas afirman que su trabajo tiene una repercusión positiva en otras esferas de su vida.

«La sociedad piensa que trabajar con pacientes moribundos nos convierte en personas tristes y apenadas pero mi trabajo tiene una repercusión positiva en mi vida familiar. No sería la misma persona que soy hoy en día si no trabajara en paliativos». (E.3).

Para finalizar, las creencias religiosas fueron descritas como un recurso de gran ayuda. Dos entrevistadas las definen como una herramienta útil tanto en pacientes como en enfermeras, sobre todo a la hora de afrontar situaciones difíciles.

«Tengo mucha fe en Dios y entonces yo descanso en Él. Le digo que mis cargas se las doy a él porque yo sé que no puedo hacer más y entonces yo hago mi parte y yo sé que hasta ahí llego». (E.2).

Los resultados en la categoría «vida personal» señalan, por un lado, la importancia de una buena relación entre compañeros. En contra de lo propuesto por García et al.²⁸, los cuales afirman que la relación de las enfermeras con los compañeros en ocasiones se percibe como una influencia negativa, las entrevistadas señalaron la importancia de la cohesión y el apoyo del equipo de trabajo, puntos de apoyo para enfrentar situaciones de desgaste emocional. Para complementar este apoyo, se reclama un espacio, tanto físico como temporal, para poder exponer sus necesidades

e intentar cubrirlas en equipo, algo que corrobora el estudio de Powel y Yuma³⁴, el cual remarca la importancia de la expresión de emociones en el lugar de trabajo. Atendiendo a la repercusión del trabajo, pese a que se pueda creer que trabajar en cuidados paliativos afecta aspectos como el estado de ánimo, los resultados indican que trabajar en la UHD tiene repercusiones positivas sobre otros ámbitos de vida, lo cual sigue la línea de investigaciones previas^{19,20}. Para finalizar, las creencias religiosas resultaron ser un elemento de apoyo para las trabajadoras y los pacientes, lo cual sigue la línea propuesta por otros autores³⁵.

En cuanto a las limitaciones del estudio, principalmente están relacionadas con la muestra de participantes y la triangulación. En el primer caso, el número de personas entrevistadas es escaso por las dificultades para encontrar trabajadores especializados en el ámbito de los cuidados paliativos, ya que se trata de una especialidad con una prevalencia muy baja. Por este motivo, y teniendo en cuenta la especificidad de la UHD, se decidió incluir a todo el equipo de enfermería pese a no cumplir los 2 años de experiencia laboral recomendados como criterio temporal mínimo²⁹. En cuanto al hecho de contar solo con mujeres, es importante recordar que la distribución entre sexos en esta profesión es tremendamente desigual. Pese a ello, sería recomendable conseguir una muestra con un porcentaje representativo de hombres. En investigaciones futuras se debe considerar el desarrollo de entrevistas en profundidad, con carácter abierto y de forma repetida en el tiempo para poder explorar mejor las vivencias de cada una de las enfermeras. Para finalizar, se debe indicar que otra limitación del presente estudio reside en no haber triangulado la información con entrevistas grupales de discusión ni con observación participante.

Conclusiones

Los resultados del presente trabajo muestran que las enfermeras que trabajan en cuidados paliativos en unidades como la UHD, la Unidad de Cuidados Intensivos o la Unidad de Geriátrica, sufren una exposición continua a situaciones traumáticas, siendo estas precursoras de la FC. No obstante, también refieren sentir una satisfacción que llega a compensar los momentos de angustia. Esta satisfacción está relacionada con tener la oportunidad de brindar cuidados que permiten al paciente en situación terminal cerrar su ciclo vital de una forma digna, cómoda y rodeado de seres queridos.

Por otro lado, los datos recogidos parecen mostrar que existen diversos factores protectores frente a la hora de evitar la FC. Entre ellos destacan el apoyo social y la cohesión y el apoyo dentro equipo de trabajo. Además, también parece fundamental la formación que dote al profesional de herramientas para autoconocerse, cuidarse y regularse a nivel emocional. Aquellos profesionales sanitarios con un alto desarrollo en estas habilidades tienen más recursos para reconocer los signos de la FC, afrontar el desgaste emocional y mantener una alta motivación. Todas estas medidas permiten mantener el bienestar psicosocial en el lugar de trabajo, lo que resulta crucial para que las enfermeras puedan desempeñar su labor de la mejor forma posible,

prestando una atención de calidad al paciente con necesidades paliativas.

Financiación

Trabajo parcialmente financiado por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo (ACIF/2017/201).

Conflicto de intereses

No existen conflictos de interés.

Agradecimientos

Agradecemos la participación de las enfermeras de la Unidad de Hospitalización a Domicilio.

Anexo 1. Guion de la entrevista

Datos sociodemográficos	¿Qué edad tienes?
	¿En qué municipio vives?
Preguntas específicas	¿Cómo se compone tu unidad familiar?
	¿Tiempo trabajado en la UHD?
	Estudios de grado, posgrado, formación profesional, etc.
	¿Podrías describir un día de trabajo en la UHD?
	¿Cómo te sientes al inicio y al final del turno y por qué?
	¿Qué te supone y cómo afecta en el trabajo y en tu vida personal y familiar el tener que trabajar con pacientes paliativos y con sus familias?
	¿Conoces los conceptos FC y SC?
	¿Han repercutido en tu salud o bienestar?
	Describe qué recursos utilizas o qué te ayuda a enfrentarte a la muerte de pacientes y a la situación familiar de dicha vivencia
	Supongamos que recibes estudiantes o personal novel en tu unidad. ¿Qué les dirías o les recomendarías para trabajar con este tipo de pacientes y familias?
	¿Has recibido algún tipo de entrenamiento o formación para poder afrontar la carga emocional que supone cuidar a este tipo de pacientes y familias? ¿Cuáles?
	¿Qué crees que ayudaría a mejorar tu práctica asistencial? ¿Qué recursos, conocimiento/habilidades adicionales son necesarias o te gustaría tener a nivel individual o colectivo?
	Si tuvieras la oportunidad, ¿cambiarías de servicio o continuarías en Cuidados Paliativos?
	¿Qué implican estas situaciones a tu institución y a tus superiores y cómo lo gestionan?
	De todo lo hablado, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar y que no haya preguntado?

Fuente: elaboración propia.

Anexo 2. Categorías, códigos y unidades de significado.

Categoría dimensión emocional

Sensación y sentimientos	Dificultades	Compasión	Crecimiento emocional
«Tienes una sensación de decir “bfff, qué mal, ¿no?” cuando tienes situaciones en las que se ve sufrimiento». (E.1)	«Te tienes que adaptar a la situación y tú también tienes días, ya que hay momentos que lo puedes llevar muy bien, pero hay días que a lo mejor tú también tienes problemas personales y se junta todo y no lo llevas tan bien». (E.2)	«Hay gente que lo ve de una forma negativa, en el sentido de que si tú sientes compasión por una persona es como que tú te sientes superior a ella [...] Es otro concepto diferente que se piensan que significa compasión» (E.1)	«Cuando comencé en esto era muy difícil no dejarme superar por el contexto, todo me impactaba y me iba a casa muy afectada. Sin embargo, poco a poco he ido mejorando mucho mi manera de reaccionar y soy capaz de gestionar mejor emociones como la frustración». (E.9)
«Cuando te sientes identificada con el paciente es mucho más duro, al menos para mí». (E.1)	«Sí, claro... ha habido temporadas en las que ha habido muchísima faena y uno de las cosas que nosotras tenemos es que no sabemos trabajar de prisa y mal. [...] Cuando tenemos una carga asistencial muy grande se nos ha notado a todos. Tanto emocional como físicamente». (E.3)	«Hay gente que dice que la compasión no se puede fatigar, no se puede cansar, como que es una fuente inagotable, pero yo pienso que tienes que estar muy trabajado para poder compartir, dar, ofrecer esa compasión sin agotarte». (E.6)	«Cuando comencé en la unidad no era capaz de percibir mis estados emocionales, pero con ayuda de las compañeras y algunas formaciones aprendí a ponerle nombre a lo que sentía». (E.7)
«Pero en este servicio hay un plus, el de las emociones. Yo pienso que este trabajo es bastante enriquecedor a nivel profesional porque ves al paciente de forma integral». (E.4)	«Tampoco vivimos en una cultura en la que se fomente la expresión de las emociones y los sentimientos, por tanto, ni nosotros mismos sabemos identificar ni exteriorizar nuestros sentimientos». (E.6)	«Realmente necesitamos conciencia plena, saber estar en el presente con tus emociones y sentimientos para poder saber tomar esa distancia con el paciente y para poder acompañarlo [...] Para mí, el recurso fundamental es conocerme y nutrirme para poder acompañar a los demás». (E.6)	«El desarrollo personal siempre ha sido importante para mí, pero esta profesión ha hecho casi imprescindible mejorar mis habilidades emocionales para minimizar el impacto que pueda tener sobre mi vida». (E.5)

Fuente: elaboración propia.

Categoría aspectos beneficiosos y angustiantes

Fatiga	Satisfacción
«Fue muy duro a la hora de sedarla ya que era ella y todo el entorno desagradable...» (E.1)	«Levantarte cada día y estar satisfecha de poder ir a trabajar en algo que te gusta y en algo que disfrutas y que sientes parte del propósito de tu vida [...] cuando te despiertas cada día y sabes que vas a algo que disfrutas, no solo a trabajar». (E.2)
«Es posible que el agotamiento emocional haya coincidido también en mi vida con malas épocas personales» (E.5)	«A mí me provoca una enorme satisfacción que a través de mi trabajo y mi formación tenga una escala de valores en mi vida personal que se ha gestado por todo esto, entonces, a mí me parece que este trabajo me da mucha más satisfacción que otra cosa». (E.3)
	«La sociedad piensa que trabajar con pacientes moribundos nos convierte en personas tristes y apenadas pero mi trabajo tiene una repercusión positiva en mi vida familiar. No sería la misma persona que soy hoy en día si no trabajara en paliativos». (E.3)

Fatiga	Satisfacción
«Llegó un momento que me encontraba cansada, cansada de tratar con enfermos paliativos o muy malitos que estaban sufriendo y familiares que también sufrían y me di cuenta de que me estaba pasando factura». (E.6)	«Para mí es como una energía muy mágica, aunque es verdad que hoy en día como que es muy tabú el tema de la muerte y de la enfermedad en nuestra cultura». (E.6)

Fuente: elaboración propia.

Categoría vida laboral diaria

Recursos y necesidades de estos	Herramientas de afrontamiento	Consejos a otros profesionales	Carga laboral
«Hace poco hablábamos de lo importante que es tener un espacio para hablar de las emociones en este trabajo». (E.3)	«Hablar con mis compañeros, el mismo día lo expresaba, me hartaba de llorar, pero a mí eso me ayudaba». (E.1)	«Les aconsejaría que intentaran no sobre implicarse y que lo más importante sería que tengan claro el concepto de que nuestra enfermería y nuestra medicina en estos casos no es para curar ni para salvar, es para ayudar en el momento de la muerte que es parte de la vida». (E.1)	«Trabajar en esta unidad requiere una alta demanda emocional por la carga psicológica que conlleva cuidar a pacientes en situación terminal». (E.7)
«Formación y habilidades de comunicación [...] También ayudan cursos de espiritualidad o de mindfulness». (E.4)	«Cualquier herramienta que te permita trabajar emociones repercutirá en una mejor gestión de las situaciones cotidianas». (E.3)	«Empatía sobre todo, que trabajen mucho la empatía, que puedan entender la situación en la que se encuentran todos, pacientes y familias, para poder entender y después saber separar». (E.5)	«En ocasiones este trabajo te sobrepasa, no cabe duda que necesitas estar muy unida a él para no abandonar». (E.8)
«Por ejemplo, una vez al mes reunimos. En mi unidad lo hemos intentado llevar a cabo, pero ha sido imposible debido a la carga asistencial» (E.9)	«El recurso fundamental es conocerme y nutrirme para poder acompañar a los demás». (E.6)	«Yo siempre recomiendo que, si te hacen preguntas respecto a la muerte y no sabes qué decir, por supuesto, que no digas nada, siempre es mejor el silencio». (E.6)	«A veces noto que las demandas son excesivas, necesitamos estar bien preparadas para que toda la carga nos afecte lo menos posible». (E.4)
	«A mí me sirve de mucho la comunicación, intentar identificar qué sentimientos he captado yo o qué sentimientos he detectado y una vez yo detecto sentimientos, intento vincularlos a necesidades» (E.3)		

Fuente: elaboración propia.

Categoría vida personal

Creencias	Apoyo	Repercusión
«A veces afronto los problemas porque tengo mucha fe en Dios y entonces yo descanso en él». (E.2)	«Momento de café y de interacción entre compañeros. como que hay muy buen equipo y te sientes muy respaldada, pues, normalmente ríes, cuentas las cosas que te han pasado y hay un buen escape». (E.1)	«En mi vida familiar te diría que también tiene una repercusión positiva. No sé si estabas esperando que te dijera que era una repercusión negativa. Es muy positiva. [...] me ha ayudado a ver la muerte de una manera más formalizada, me ha ayudado a entender la enfermedad en cualquier momento de la vida, me ha ayudado a establecer prioridades y dar gracias por la salud y me ha ayudado a saber organizarme lo antes posible cuando viene la enfermedad». (E.3)

Creencias	Apoyo	Repercusión
«Siempre pregunto si es creyente y si lo es pues les digo que si creen que hay algo más deben irse tranquilos [...] creer en algo da paz [...] si no es creyente, para mí es mucho más difícil». (E.9)	«Simplemente de escucha... que yo creo que lo hacemos de manera automática incluso, porque a veces vienes a las reuniones y lo cuentas todo [...] no es difícil ver a alguien llorando en las reuniones como una expresión de las emociones que necesitas en ese momento y proporcionas apoyo sin haberlo premeditado» (E.3)	«Yo creo que depende, no solo del trabajo, sino también de las circunstancias de la persona, entonces, depende en qué circunstancia pues sí que te puede afectar más o menos, y ya el tema hormonal ya ni te cuento que a veces estamos más "tontonas" que otras veces». (E.7)

Fuente: elaboración propia.

Bibliografía

- Vivar C, Orecilla E, Gómara L. «Es más difícil»: experiencias de las enfermeras sobre el cuidado del paciente con recidiva con cáncer. *Enferm Clin*. 2009;19:314–21, <http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2009.07.008>.
- Perez E, Altisent R, Rocafort J. Definition of compassion in healthcare: A systematic literature review. *Int J Palliat Nurs*. 2016;22:599–606.
- Alba-Martin R. *Burnout* en enfermería: prevalencia y factores relacionados en el medio hospitalario. *Rev Cient Soc Esp Enferm Neurol*. 2015;41:9–14.
- Maslach C, Jackson S, Leiter MP. *Maslach Burnout Inventory*. 3.^a ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press; 1996.
- Stamm B.H. The concise proQOL manual [monografía en Internet]. 2nd ed. 2010. [consultado Nov 2019]. Disponible en: http://www.proqol.org/uploads/ProQOL-Concise_2ndEd_12-2010.pdf.
- Braunschneider H. Preventing and managing compassion fatigue and burnout in nursing. *ESSAI*. 2013;11:14–8.
- Potter P, Deshields T, Divanbeigi J, Berger J, Cipriano D, Norris L, et al. Compassion fatigue and burnout: Prevalence among oncology nurses. *CJON*. 2010;14:E56–62.
- Nolte A, Downing C, Temane A, Hastings-Tolsma M. Compassion fatigue in nurses: A metasynthesis. *J Clin Nurs*. 2017;26:4364–78.
- Joinson C. Coping with compassion fatigue. *Nursing*. 1992;22:116–8.
- Grupo de Trabajo sobre Espiritualidad en Cuidados Paliativos de la SECPAL. El acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Una introducción y una propuesta [consultado 19 Dic 2019]. Disponible en: http://www.secpal.com/%5CDocumentos%5CBlog%5Carchivo_9.pdf.
- Ley C. Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized. En: Figley C, editor. *Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized*. New York: Brunner-Routledge; 1995. p. 1–20.
- Hinderer KA, von Rueden KT, Friedmann E, McQuillan KA, Gilmore R, Kramer B, et al. Burnout, compassion fatigue, compassion satisfaction and secondary traumatic stress in trauma nurses. *J Trauma Nurs*. 2014;21:160–9.
- Marín M. Prevención de burnout y fatiga por compasión: evaluación de una intervención grupal. *JBHSI*. 2017;9:117–23.
- Boyle DA. Compassion fatigue: The cost of caring. *Nursing*. 2015;45:48–51.
- Abendroth M, Flannery J. Predicting the Risk of compassion fatigue. A study of hospice nurses. *JHPN*. 2006;8:346–56.
- Lepnurm R, Lockhart WS, Keegan D. A measure of daily distress in practicing medicine. *Can J Psychiatry*. 2009;54:170–80.
- Kearney MK, Weininger RB, Vachon MLS, Harrison RL, Mount BM. Self care of physicians caring for patients at the end of life. Being connected... A key to my survival. *JAMA*. 2009;301:1155–64.
- Caro M, San-Martín M, Delgado R, Vivanco C. Empatía, soledad, desgaste y satisfacción personal en enfermeras de cuidados paliativos y atención domiciliar de Chile. *Enferm Clin*. 2017;27:379–86.
- Sansó N, Galiana L, Oliver A, Pascual A, Sinclair S, Benito E. Palliative care professionals' inner life: Exploring the relationships among awareness, self-care and compassion satisfaction and fatigue, burnout and coping with death. *J Pain Symptom Manag*. 2015;50:200–7.
- Alkema K, Linton JM, Davies R. A study of the relationship between self-care, compassion satisfaction, compassion fatigue, and burnout among hospice professionals. *J Soc Work End Life Palliat Care*. 2008;4:101–19.
- Aycock N, Boyle D. Interventions to manage compassion fatigue in oncology nursing. *CJON*. 2009;13:183–91.
- Suárez C, del Moral G, González MT. Consejos prácticos para escribir un artículo cualitativo publicable en Psicología. *Interv Psicosoc*. 2013;22:71–9.
- Valles M. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. 1.^a ed. Madrid: Editorial Síntesis; 1999.
- Fernández L. Fichas para investigadores: ¿cómo analizar datos cualitativos? Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona; 2006.
- Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Fortaleza, Brasil, octubre del: 64.^a Asamblea General; 2013 [consultado 5 Dic 2019]. Disponible en: <http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fdinvestigacion/fd-evaluacion/fd-evaluacion-etica/investigacion/Declaracion-Helsinki-2013-Esp.pdf>.
- Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del Estado de 6 de diciembre del 2018, núm. 294, p. 119788 a 119857.
- Ray S, Wong C, Dawn W, Heaslip K. Compassion satisfaction, compassion fatigue, work life conditions and burnout among frontline mental health care professionals. *Traumatology*. 2013;19:255–67.
- García R, Fernández J, Martínez F. Implicación de las enfermeras en su profesión. Un estudio cualitativo sobre el engagement. *Enferm Clin*. 2017;27:153–62.
- Anderson E, Salickiene Z, Rosengren K. To be involved —A qualitative study of nurses' experiences of caring for dying patients. *Nurse Education Today*. 2015;38:144–9.
- Colell Brunet R, Limonero García JT, Otero MD. Actitudes y emociones en estudiantes de enfermería ante la muerte y la enfermedad terminal. *Invest Salud*. 2003;5:0.
- Orellana-Rios CL, Radbruch L, Kern M, Regel YU, Anton A, Sinclair S, et al. Mindfulness and compassion-oriented practices at work reduce distress and enhance self-care of palliative care teams: A mixed-method evaluation of an

- “on the job” program. *BMC Palliat Care*. 2018;17:1–15, <http://dx.doi.org/10.1186/s12904-017-0219-7>.
32. López-Medina I, Sánchez-Criado V. Percepción del estrés en estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas. *Enferm Clin*. 2005;15:307–13.
 33. Kavalieratos D, Siconolfi DE, Steinhauer KE, Bull J, Arnold RM, Swetz KM, et al. “It is like heart failure. It is chronic... and it will kill you”: A qualitative analysis of burnout among hospice and palliative care clinicians. *J Pain Symptom Manage*. 2017;53:901–10, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2016.12.337>.
 34. Powel T, Yuma P. Supporting community health workers after a disaster: Findings from a mixed-methods pilot evaluation study of a psychoeducational intervention. *Disaster Med Public Health Prep*. 2016;10:754–61.
 35. Valiente-Barroso C, García-García E. La religiosidad como factor promotor de salud y bienestar para un modelo multidisciplinar de atención psicogeriatrica. *Psicogeriatría*. 2010;2:153–65.